

**Heili Piho-Arna**

SA Eesti Agrenska fondi sotsiaalteenuste koordinaator
Tartu ülikooli õppekava „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ magistrant

Tugiteenused harvikaigusega lastele vajavad suuremat tähelepanu

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse kehva korralduse tõttu on kitsikuses nii kasutajad kui ka teenuseosutajad ja kannatab teenuste kvaliteet.

Euroopa sotsiaalfondi TAT toel 2015. aastal alustatud projekt „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ lõppes 2022. aastal. Selle käigus hinnati erivajadusega last kasvatavate perede vajadust lapsehoiu-, tugiisiku- ja sotsiaaltransporditeenuse järele ning toetati lapsevanemate töötamist, õppimist ja igapäevast toimetulekut keskselt korraldatud ja rahastatud tugiteenustega.

Kuigi nüüd saab nimetatud teenuseid taotleda kohalikust omavalitsusest (KOV) ja rahastus on suunatud otse neile, ei ole teenuste taotlemine, korraldamine ja osutamine muutunud oluliselt hõlpsamaks. Teenustundide keskmine hulk on jäänud samale tasemele ja teenustunni hindu on vaid veidi tõstetud, mis on muutnud erivajadustega lastele ja nende peredele toe

tagamise, hoidmise ning teenust osutavate inimeste võimestamise üha keerulisemaks.

Teenuste korraldus on keeruline

Erivajadustega laste pered seisvad tugiteenuste taotlemisel ikka silmitsi lapse abivajaduse korduvhindamise ja kindlas mahus tugiteenuste korduvtaotlemisega, paljudel tuleb asjaajamine ette võtta lausa mitu korda aastas. Mitu KOV-i on püüdnud dokumentide alusel korduvtaotlemist vähendada, määrares lapsele korraga suurema teenustundide arvu ning erandkorras võimaldanud ka kasutada kindlaks määratud teenusmahtu terve kalendriaasta vältel. Siiski tuleb ette, et tugiisiku- ja lapsehoiuteenust määratakse lastele 50–100 tunni kaupa, millest jätkub suure hooldusvajadusega lapse vanemate tööhõives või ka koolitustel

osalemise võimaldamiseks vaevalt mõneks kalendrikuuks. Lisaks toob abivajaduse korduvtõendamine nii erivajadustega laste vanematele, hooldajatele, eestkostjatele kui ka teenuseosutajatele kaasa kohustuse sügava või raske ning pöördumatu diagnoosiga laste terviseandmeid iga kord ajakohastada, mis põhjustab teenuse osutamise ja kasutamise seisakuid.

Lapsehoiu- ja tugisikuteenuse kehva korralduse tõttu on kitsikuses nii kasutajad kui ka teenuseosutajad ja kannatab teenuste kvaliteet. Omavalitsused ei ole valmis teenuseosutajale rohkem maksuma, seega on üha keerulisem leida perele kauemaks toeks jäävaid lapsehoidjaid ja tugisikuid. Nimetatud tugitöötajad saaksid aidata perel kasutada rehabiliteerivaid tugiteenuseid, toetada last igapäevategevuses, abistada haridusasutuses, avalike teenuste kasutamisel ja kodus. Need võimalused aga jäävad kasutamata, kui KOV-ide lapsehoiu- ja tugisikuteenuse toetussummad ei taga tugitöötajatele Eesti tööturul konkureerivat tunnitasu.

Harvikaigusega lapse teenusevajadus

Umbes kolmandikul KOV-i tugi- ja hooldusteenuseid vajavatest lastest on harva esinev haigus ehk harvikaigus. Nende laste ja nende perede tugiteenuste vajadus kuulub küll erivajadustega laste sotsiaalkaitssüsteemi, kuid võttes arvesse nende haiguste vähest esinemissagedust ning komplekssust, on sageli tegemist kõrgeandatud hooldus- ja järelevalvevajadusega lastega, kelle tarvis napib nii tugiteenuseid, oskustöötajaid kui ka teenusmahtu.

Sellest tulenevalt lasub harvikaigusega lapse vanemal suur koormus. Nad peavad igal aastal mitu korda taotlema teenusmahude suurendamist, teenuseid planeerima, rahastust jälgima ja esitama kord kuus

aruandeid, kui perele leitakse tugisik, lapsehoidja või koht ööpäevaringsel ajutisel intervallhooldusel. Seda ka siis, kui sotsiaaltöötajal või lastekaitse spetsialistil on tegelikult piisav ülevaade lapse keerukast abivajadusest ning tema rasket või sügavat puuet ei peaks sellest vaatenurgast korduvalt kirjeldama ega tõestama.

Erivajadustega laste pered seisvad tugiteenuste taotlemisel ikka silmitsi lapse abivajaduse korduvhindamise ja kindlas mahus tugiteenuste korduvtaotlemisega, paljudel tuleb asjaajamine ette võtta lausa mitu korda aastas.

Sageli on harvikaigused pöördumatu kuluga ja paranemisvõimalus on äärmiselt väike. Harvikaiguse sümptomitest või mitmikdiagnoosist olenevalt võib laps vajada ööpäevaringset ja igapäevast mahukat tuge hooldustoimingutes ja ravimite manustamisel, samuti tervisliku seisundi pidevat, nii mõnigi kord eriseadmetega jälgimist. Praegune tugiteenuste ja toetuste korraldus ei taga harvikaigustega lastele terviklikku tuge: tugiteenused leevendavad lapsevanemate hoolduskoormust vaid vähesel määral, toetustest ei piisa suurenenud ravikulude ja rehabilitatsiooniteenuste katmiseks ega haigusega seotud tagasilanguse ennetamiseks.

Näiteks pakutakse harvikaigusega laste peredele lapsehoiu- ja tugisikuteenust praegu keskmiselt ühe lapse kohta samas mahus nagu teistele raske ja sügava puudega lastele ehk keskmiselt 100–200 tundi aastas, mis teeb vaid 8–16 tundi kalendrikuus. Lapsega seotud suur hoolduskoormus ei lase vanematel aktiivselt osaleda tööturul ja see

seab löögi alla pere majandusliku ellujäämise ning emotsionaalse sidususe.

Tuge vajavad nii pere kui ka abistajad

Pered, kus on suurt hoolt vajav harvikaiguga laps, on oma murega üksi ka seetõttu, et enamasti ei ole sarnaste unikaalsete vajadustega, sama diagnoosiga teist last meie väikeses Eestis või leidub vaid üksikuid, kelle peredelt saada vastastikust nõu ja tuge.

Suure hoolduskoormusega peredel on vaja ka puhkeaga, võrdseid võimalusi tööturul osalemiseks ja hoolduskoormuse hajutamiseks.

Rahvusvahelised internetifoorumid, kus jagada muresid ja rõõme, ei asenda enamasti vahetut kogemust, mida võib ammutada teiselt samas olukorras ja sarnaste vajadustega last kasvatavalt perelt. Kuigi harvikaigustega laste peredel on pärast kliinilist nõustamist võimalik kasutada ka psühholoogilist nõustamist, jääb peredel siiski puudu emotsionaalsest toest, kogemusnõustamisest, tugirühmadest ja koostööseminaridest. Suure hoolduskoormusega peredel on vaja ka puhkeaga, võrdseid võimalusi tööturul osalemiseks ja hoolduskoormuse hajutamiseks.

Võttes arvesse harvikaigusega lapse vajadust kasutada tugisiku- ja lapsehoiuteenust suuremas mahus ning teenustundide madalat hinda, on keeruline leida harvikaigustega laste toetamiseks sobiva ettevalmistusega, sealhulgas õenduspädevusega tugisikuid ja lapsehoidjaid. Häta jäävad nii tugisikuteenuse osutajad (sh MTÜ-d, KOV-id ja nende allasutused) kui ka pered ise, sest sobivat tugipersonali pole kuskilt võtta.

Praegune tugisikute ja lapsehoidjate väljaope on liiga üldine ning käsitleb vaid vähesel määral harvikaiguste spetsiifikat. Tööle asuvad tugispetsialistid omandavad oskusi ja teadmisi enamasti teenuseosutaja ja lapsevanemate koostöö käigus. Lapse eripärade arvestamisel ja vajaduse täitmisel tekivad igapäevatoos tihti ka ootuste ja tugisiku või lapsehoidja oskuste vastuolud.

SA Eesti Agrenska fond on püüdnud leida tugisikute ja lapsehoidjate kovichoonigruppide loomise võimalusi, mis aitaksid vähendada tugitöötajate läbipõlemisriski, lahendada probleeme ja võimestada töötajaid turvalistes arutelurühmades. Kuigi kovichoonigruppide kulusid ei saa katta tugiteenuste rahastusest ja puudub kõiki teenuseosutajaid hõlmav korraldus, on see siiski vajalik toetusvõimalus, et vältida harvikaigusega laste peredega töötavate spetsialistide töölt lahkumist ja toetada nende säilenõtkust.

Teenuste arendamise võimalused

Harvikaigusega laste tugisiku- ja lapsehoiuteenuse taotlemise ning korraldamise lihtsustamise, perede hoolduskoormuse ühtlasema jaotamise ja harvikaigusega lapse tugiteenuste arendamise ettepanekud on järgmised.

- Püsiva lapsehoiu- või hooldusvajadusega lapse teenustundide vajaduse arvestamise esmaseks aluseks võiks võtta eelneval aastal kasutatud teenustundide arvu, mida oleks võimalik vajaduse korral edaspidi muuta.
- Lapse hooldus- või abivajaduse hinnangud võiksid kehtida kauem, mis aitaks vähendada vajadust samade hinnanguvormide alusel korduvalt tõendada abivajadust.
- Tugisikutele ja lapsehoidjatele tuleks keskselt korraldada supervisioone ja

kovisioonigruppe. Teine võimalus on leida selleks lisaraha tugiteenuste osutajatele.

- Harvikaigustega laste perede kogemusi nõustamine, tugi- ja arutelugrupid peaks olema keskselt korraldatud ja rahastatud või tuleks leida lisaraha tugiteenuste osutajatele nende korraldamiseks.
- Tugiisikute ja lapsehoidjate koolituskavadesse, eripedagoogika ning õendus-teenuse õppekavadesse tuleks lisada harvikaigustega laste ja täiskasvanute õppevaldkond.

Kokkuvõte

Erivajadustega lastele, sh harvikaigustega lastele, vajalikus mahus lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse korraldusega jäävad 2022. aastal lõppenud Euroopa sotsiaalfondist rahastatud projekti järel hätta nii pered, teenuseosutajad kui ka KOV-id. Tugisüsteemide ja -teenuste sisuline piiratus ning teenuste ja toetuste kasutusmaht

seavad ohtu laste tervise ning perekonna tervikliku toimetuleku.

Tööle asuvate tugispetsialistide ettevalmistus kujuneb teenuseosutaja ja lapsevanemate koostöö käigus.

Erivajadustega laste tugiteenuste taotlemisel, korraldamisel ja osutamisel on ka nii mõndagi röömustavat. Esile saab tuua erivajadustega, sh harvikaigusest tulenevat kõrgendatud hoolt vajavate laste peresid toetavaid kohalikke omavalitsusi, sätasilmseid tugiisikuid ja lapsehoidjaid ning õhinapõhiseid teenuseosutajaid. Tunda on nii meditsiini-, haridus- kui ka sotsiaalvaldkonna suuremat koostööd. Erivajadustega laste võrgustiku liikmete hulgas on juhtumite alusel kaasatud võrdväärselt nii teenuseosutajad kui ka pere tugiisikud ja lapsehoidjad. 